

Diarreia aguda · hidratação e zinco

Na diarreia aguda pediátrica, a hidratação salva vidas. Classifique desidratação e aplique planos A, B ou C; zinco reduz duração em contextos de risco.

Sinais de desidratação

Lembre - Sinais de desidratação

Olhos fundos, sede, elasticidade cutânea !“, mucosas secas, fontanela deprimida, diurese !“, letargia/ irritabilidade. Sangue no choque: extremidades frias, TE enchimento >2–3 s, pulso fino.

Memória obrigatória de pediatria de R1 e APS.



Conduta

- Manter leite materno; evitar anti-diarréicos inibidores de motilidade
- Ondansetrona pode ajudar vômitos e sucesso da TRO em selecionados
- ATB: disenteria com sangue + febre / Shigella suspeita / cólera em surto — não rotina viral
- Zinco por 10–14 dias conforme protocolo OMS/MS em crianças elegíveis

Red flags

Sinal | Ação

- Sangue + toxemia | Avaliar bacteriana / internar
- Fontanela abaulada | Pensar meningite associada
- Bilioso / distensão | Obstrução — cirurgia
- Desnutrido grave | Protocolo específico de reidratação

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Não use loperamida em crianças pequenas. No plano C, volume inicial de SF 0,9% em bolos e reavaliação — cuidado com desnutrido grave (risco de sobrecarga/ falência).